



PROCEDIMENTO PADRÃO Nº 009

PADRONIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DO NÚCLEO ABA

FÁBIO COELHO



SUMÁRIO

1	PADRONIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO ABA.....	3
1.1	OBJETIVO GERAL	3
1.2	DEFINIÇÃO OPERACIONAL	3
1.3	DIRECIONAMENTO DA INTERVENÇÃO ABA.....	3
1.4	ESTRUTURA DO NÚCLEO ABA	4
1.5	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO BASEADO EM ABA.....	4
1.5.1	ANALISTA DO COMPORTAMENTO / SUPERVISOR	4
1.5.2	SUPERVISOR DO NÚCLEO ABA.....	5
1.6	EQUIPE TERAPÊUTICA.....	6
1.7	INDICADORES DE DESEMPENHO DA EQUIPE TERAPÊUTICA	7
1.8	MODELO DE <i>CHECKLIST</i> PARA SUPERVISÃO DE DESEMPENHO TERAPÊUTICO	8
1.9	ACOMPANHANTES TERAPÊUTICOS	9
1.9.1	FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS DO AT	9
1.9.2	COMPORTAMENTOS ESPERADOS DO AT.....	10
1.9.3	CRITÉRIOS DE QUALIDADE NO DESEMPENHO DO AT.....	10
1.10	SOCIAUTISM: COLETA DE DADOS	11
1.11	SUPERVISÃO	11
1.11.1	FREQUÊNCIA RECOMENDADA PARA TERAPEUTAS	11
1.11.2	FREQUÊNCIA RECOMENDADA PARA ATs	12
1.12	TREINAMENTO DE PAIS (MODELO BST).....	13
1.13	INDICADORES DE QUALIDADE DO NÚCLEO ABA	13
1.14	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
	REFERÊNCIAS.....	14



1 PADRONIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO ABA

1.1 OBJETIVO GERAL

Oferecer atendimento intensivo e sistemático a clientes que se beneficiem da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com foco em intervenções baseadas em evidências, individualizadas e ajustadas às necessidades do aprendiz e de seu contexto.

1.2 DEFINIÇÃO OPERACIONAL

Refere-se ao conjunto de diretrizes que orientam a estruturação, o funcionamento e a avaliação do Núcleo Intensivo ABA, assegurando coerência técnica, ética e metodológica em todas as etapas do processo terapêutico.

1.3 DIRECIONAMENTO DA INTERVENÇÃO ABA

Abaixo, são apresentados os critérios que orientam a prática no Núcleo ABA, com foco em metas claras e mensuráveis.

Item	Direcionamento	Comportamento observável e mensurável
1	Intervenção intensiva	Número de horas superior a 10 ou 15 horas semanais por aprendiz
2	Objetivos terapêuticos claros	Metas descritas conforme o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), com critérios objetivos de aquisição, manutenção, linguagem científica, clara, concisa, observável e mensurável
3	Procedimentos replicáveis	Planos de ensino escritos com passo a passo validado, atendendo à dimensão tecnológica da ABA
4	Registro sistemático	Coleta de dados em todas as sessões via SociAutism ou fichas
5	Análise de dados	Relatórios mensais com gráficos e descrição dos progressos
6	Participação da equipe	Reuniões semanais de alinhamento; tarefas atribuídas por função; supervisões com Acompanhantes Terapêuticos (ATs), equipe interdisciplinar e equipe terapêutica
7	Generalização dos comportamentos	Procedimentos planejados para uso em casa, escola e comunidade



1.4 ESTRUTURA DO NÚCLEO ABA

A estrutura do Núcleo ABA é organizada de forma a garantir a efetividade e a consistência das intervenções, promovendo a integração entre equipe, espaços, rotinas e tecnologia. Cada componente contribui para o alinhamento técnico e ético das práticas baseadas na ABA. A seguir, são descritos os principais elementos que compõem essa estrutura:

- **Ambientes terapêuticos:** Espaços físicos organizados por áreas específicas de desenvolvimento, com materiais e recursos adaptados às metas do plano de intervenção individual.
- **Equipe multidisciplinar:** Formada por um supervisor geral ou responsável técnico (RT), supervisores de área, ATs e terapeutas especializados, promovendo a atuação colaborativa e integrada.
- **Rotinas estruturadas:** Incluem supervisões regulares, planejamento clínico, aplicação de programas, coleta e análise de dados, garantindo a previsibilidade e qualidade do processo terapêutico.
- **Fluxo de comunicação:** Estabelecido entre supervisores, terapeutas, escola e famílias, promovendo alinhamento constante entre os contextos de intervenção e os responsáveis pelo cuidado do cliente.
- **Tecnologia:** Utilização do aplicativo SociAutism, que permite o registro de dados em tempo real, facilitando o acompanhamento da intervenção, a tomada de decisões clínicas e a comunicação entre profissionais.

1.5 OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO BASEADO EM ABA

1.5.1 ANALISTA DO COMPORTAMENTO / SUPERVISOR

Responsável por desenvolver e gerenciar a intervenção baseada em ABA, alinhando sua atuação ao código de ética profissional, à prática ética da ABA, à literatura científica e às prioridades e valores do cliente, da família e de seu contexto social, econômico e cultural.



1.5.2 SUPERVISOR DO NÚCLEO ABA

Profissional responsável por intermediar processos clínicos, supervisionar o fluxo entre os terapeutas do núcleo ABA, terapeutas de outras áreas e ATs. Também garante a implementação qualificada das intervenções, o treinamento da equipe direta e o acompanhamento técnico dos familiares, em alinhamento com o supervisor geral.

Área de atuação	Comportamento observável	Frequência/prazo	Evidência mensurável
Planejamento de treinamento dos ATs	Elaborar e encaminhar, com antecedência, o cronograma de supervisões e treinamentos à equipe de terapeutas e à supervisão geral	Mensal/conforme demanda	Cronograma/documento protocolado no sistema
Supervisões diretas	Conduzir supervisões diretas com terapeutas da área comportamental, e também com equipe multidisciplinar	Por ciclo de intervenção	Registros assinados das supervisões; vídeos e formulários preenchidos
Coleta e organização de dados	Consolidar os dados do caso em conjunto com o terapeuta do núcleo ABA e a supervisão geral	Antes de cada reunião de caso	Documento de compilação de dados
Comunicação com a supervisão de outras áreas	Reportar condutas, dificuldades e riscos relacionados aos ATs, pais ou demais membros da equipe	Sempre que necessário	E-mails, atas de reuniões ou relatórios de acompanhamento
Uso do sistema SociAutism	Treinar ATs ou acompanhar esse treinamento no uso do sistema para registro de dados, solicitação de vídeos e preenchimento de relatórios semanais	No início do contrato e em revisões periódicas	Relatórios lançados no sistema e <i>feedbacks</i> sobre o uso correto
Supervisão semanal dos ATs	Supervisionar a aplicação dos programas e registros, assegurando a integridade dos procedimentos e a qualidade da intervenção	Semanal	<i>Checklist</i> de integridade; vídeos supervisionados
Apoio na avaliação comportamental	Participar da coleta e análise de dados durante avaliações realizadas pelos terapeutas, como VB-MAPP e ABLLS-R, por exemplo	No início da intervenção (fase de avaliação)	Registros nos protocolos de avaliação
Articulação interdisciplinar	Integrar estratégias de intervenção com escola, residência, demais profissionais e contextos comunitários	Conforme critério de supervisão dos terapeutas	Registros de reuniões e comunicações com a rede
Supervisão do relacionamento com pais	Conduzir reuniões mensais e aplicar o treinamento de pais, orientando práticas e metas conforme o plano de intervenção	Mensal	Atas, registros de reuniões e protocolos preenchidos
Aliança terapêutica e ética	Manter relação empática e colaborativa com pais e equipe; identificar riscos e comunicá-los de forma ética	Contínuo	Avaliações de clima institucional; <i>feedbacks</i> da equipe e das famílias



1.6 EQUIPE TERAPÊUTICA

A equipe terapêutica do Núcleo ABA é composta por profissionais responsáveis pela elaboração, implementação e revisão contínua das intervenções, com base nos princípios da Análise do Comportamento Aplicada. As atribuições abaixo descrevem as condutas esperadas, sua frequência e as formas de verificação e registro:

1. COMUNICAÇÃO COM A SUPERVISÃO DE ÁREA

- **Comportamento observável:** Participar de reuniões clínicas, responder de forma clara e objetiva a demandas escritas e verbais, além de relatar dificuldades e avanços relacionados aos casos.
- **Frequência/prazos:** Contínua, conforme a rotina da equipe.
- **Evidência mensurável/produto gerado:** Atas de reuniões assinadas, e-mails respondidos e registros formais de comunicação com a supervisão.

2. AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR

- **Comportamento observável:** Aplicar instrumentos padronizados e protocolos clínicos em parceria com profissionais de outras áreas, respeitando os critérios técnicos e éticos estabelecidos.
- **Frequência/prazos:** No início da intervenção e anualmente.
- **Evidência mensurável/produto gerado:** Relatórios de avaliação contendo data, assinatura e parecer técnico conclusivo.

3. DISCUSSÃO DO PDI

- **Comportamento observável:** Contribuir com metas e estratégias na construção ou revisão do PDI.
- **Frequência/prazos:** Após seis meses de intervenção com revisão do PDI e após doze meses com reavaliação.
- **Evidência mensurável/produto gerado:** Registro formal da reunião do PDI e documentação das metas individualizadas atualizadas.



4. PLANEJAMENTO INDIVIDUALIZADO

- **Comportamento observável:** Desenvolver objetivos terapêuticos específicos, observáveis e mensuráveis, baseados nos dados das avaliações e alinhados ao PDI do cliente.
- **Frequência/prazos:** No prazo máximo de 50 dias após a avaliação inicial.
- **Evidência mensurável/produto gerado:** Plano terapêutico escrito, devidamente anexado ao PDI.

5. IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

- **Comportamento observável:** Aplicar, durante as sessões, os procedimentos baseados em evidências definidos no plano de ensino, registrando dados com regularidade e promovendo ajustes sempre que necessário.
- **Frequência/prazos:** A cada sessão terapêutica.
- **Evidência mensurável/produto gerado:** Fichas de registro preenchidas, vídeos de aplicação e gráficos de desempenho atualizados.

6. REAVALIAÇÃO CONTÍNUA DOS OBJETIVOS

- **Comportamento observável:** Analisar mensalmente a efetividade das estratégias utilizadas e propor modificações nos programas quando necessário.
- **Frequência/prazos:** Mensal.
- **Evidência mensurável/produto gerado:** Planos terapêuticos revisados, gráficos atualizados e registros clínicos.

1.7 INDICADORES DE DESEMPENHO DA EQUIPE TERAPÊUTICA

Para avaliar a qualidade do trabalho clínico realizado pela equipe terapêutica, são utilizados os seguintes indicadores de desempenho:

- **Entrega do relatório de avaliação:** Deve ser realizada em até 50 dias úteis após a avaliação inicial.
- **Participação em reuniões clínicas:** Espera-se um índice de comparecimento igual ou superior a 80%.



- **Atualização dos objetivos no PDI:** 100% dos objetivos devem ser atualizados dentro dos prazos previstos.
- **Aderência ao plano terapêutico:** O profissional deve alcançar ao menos 90% de fidelidade na execução dos procedimentos definidos no plano.
- **Registro de dados por sessão:** É exigido que 100% das sessões supervisionadas pelos ATs apresentem registros completos.
- **Satisfação da família com o atendimento:** Deve atingir uma média igual ou superior a 80% em pesquisas internas de avaliação.

1.8 MODELO DE *CHECKLIST* PARA SUPERVISÃO DE DESEMPENHO TERAPÊUTICO

Avalie cada item a seguir com base na frequência e na qualidade da execução, marcando a opção correspondente. Este instrumento pode ser utilizado em momentos formais de supervisão ou como ferramenta de autoavaliação.

Legenda das colunas:

- **Adequado (A):** Realiza de forma consistente, com qualidade técnica satisfatória.
- **Parcial (P):** Realiza de maneira irregular ou com necessidade de ajustes.
- **Inadequado (I):** Não realiza ou executa de forma insatisfatória.

Item	A	P	I
Mantém comunicação clara e objetiva com supervisores	☐	☐	☐
Realiza avaliações com fundamentação técnica adequada	☐	☐	☐
Participa ativamente das reuniões clínicas e do PDI	☐	☐	☐
Constrói objetivos mensuráveis e coerentes com as necessidades do cliente	☐	☐	☐
Registra os dados por sessão de forma organizada e regular	☐	☐	☐
Revisa os objetivos com base nos dados e propõe ajustes	☐	☐	☐
Integra suas ações com as de outros profissionais da equipe	☐	☐	☐
Demonstra empatia e constrói relação de confiança com família e cliente	☐	☐	☐



1.9 ACOMPANHANTES TERAPÊUTICOS

O AT é responsável por executar os procedimentos definidos pelo supervisor ou terapeuta do núcleo, atuando sem autonomia técnica em ambientes variados (clínica, escola, domicílio).

1.9.1 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS DO AT

O papel do AT é fundamental para garantir a continuidade e a fidelidade dos programas terapêuticos propostos pela equipe técnica. A seguir, são descritas suas principais atribuições e o escopo de sua atuação no Núcleo ABA.

- **Vínculo hierárquico:** O AT atua sob supervisão direta de um Analista do Comportamento, não possuindo autonomia para tomar decisões técnicas, devendo seguir integralmente as orientações recebidas.
- **Locais de atuação:** O AT desenvolve suas atividades em múltiplos contextos nos quais o cliente está inserido, incluindo ambiente clínico, escolar e domiciliar, respeitando as demandas específicas de cada espaço.
- **Papel principal:** Sua função central é aplicar as intervenções previamente planejadas pela equipe técnica, assegurando a execução fiel dos procedimentos estabelecidos e realizando o registro sistemático de dados por meio da plataforma SociAutism.
- **Foco de atuação:** O AT atua diretamente no ensino de habilidades adaptativas e no manejo de comportamentos que interferem na aprendizagem e no convívio social, sempre com base nos princípios da ABA.



1.9.2 COMPORTAMENTOS ESPERADOS DO AT

Responsabilidade	Comportamento observável	Frequência/indicador de qualidade
Participação ativa nas supervisões	Participar das supervisões presenciais ou remotas previamente agendadas	Presença em 100% das supervisões agendadas
Pontualidade e assiduidade	Chegar com até 5 minutos de antecedência aos atendimentos	Atrasos em menos de 10% dos atendimentos
Execução de programas	Aplicar os procedimentos conforme descrito no plano de ensino	Fidedignidade $\geq 90\%$ em observações diretas
Comunicação com o supervisor	Relatar semanalmente dificuldades, dúvidas ou progressos durante as supervisões	Comunicação registrada ao menos uma vez por semana
Registro de dados	Preencher relatórios com a descrição das atividades e dados de desempenho	Relatórios entregues semanalmente, dentro do formato e prazo estabelecidos
Envio de vídeos	Gravar e enviar vídeos semanais da aplicação dos procedimentos	Um vídeo por semana, com clareza e foco nos alvos definidos
Postura ética e profissional	Manter sigilo, respeitar o cliente e seguir as orientações técnicas, sem improvisações	Ausência de advertências éticas ou condutas inadequadas

1.9.3 CRITÉRIOS DE QUALIDADE NO DESEMPENHO DO AT

Categoria	Excelente	Bom	Razoável
Supervisão	Participa, contribui e aplica os <i>feedbacks</i> de forma constante	Participa e aplica parcialmente os <i>feedbacks</i>	Participa, mas com baixa aderência às mudanças propostas
Execução técnica	Aplica os programas com precisão e registra dados confiáveis	Aplica com leve variação; registros suficientes	Aplica com imprecisão ou frequência abaixo do recomendado
Comunicação	Antecipada, objetiva e com foco em soluções	Regular e informativa	Tardia, confusa ou insuficiente
Postura profissional	Sempre pontual, ético e comprometido	Pontual e ético, com falhas pontuais	Atrasos frequentes ou falhas éticas recorrentes



1.10 SOCIAUTISM: COLETA DE DADOS

O SociAutism é um aplicativo voltado para a coleta digital de dados das intervenções baseadas na ABA. Ele oferece diversos benefícios, como praticidade, economia de tempo, maior organização, precisão nos registros e geração automática de gráficos atualizados de desempenho, facilitando o monitoramento da evolução do cliente.

As funções relacionadas ao uso do SociAutism estão distribuídas da seguinte forma:

- **Coleta de dados:** Realizada diariamente pelos ATs e terapeutas responsáveis pela intervenção.
- **Análise e fornecimento de *feedback*:** Realizada mensalmente pelo supervisor, com base nos dados coletados, a fim de avaliar o progresso e orientar os ajustes necessários.
- **Compartilhamento de informações com os pais:** Também de responsabilidade do supervisor, ocorre mensalmente, garantindo a transparência e o envolvimento da família no acompanhamento do desenvolvimento do aprendiz.

1.11 SUPERVISÃO

A supervisão dos terapeutas é fundamental para assegurar a qualidade técnica, ética e colaborativa das intervenções. Esse processo deve ocorrer de forma contínua, envolvendo tanto a supervisão entre profissionais da mesma área quanto a supervisão interdisciplinar, promovendo alinhamento entre as diferentes especialidades envolvidas no atendimento.

1.11.1 FREQUÊNCIA RECOMENDADA PARA TERAPEUTAS

A supervisão entre terapeutas é fundamental para garantir a consistência e a qualidade das intervenções. A seguir, as frequências recomendadas conforme o nível de qualidade desejado:

NÍVEL RAZOÁVEL (MÍNIMO)

- **Supervisão entre terapeutas da mesma área:** 1 hora mensal.
- **Supervisão interdisciplinar** (entre diferentes áreas): 1 hora mensal.
- **Formato sugerido:** Preferencialmente presencial ou remota.



NÍVEL BOM

- **Supervisão entre terapeutas da mesma área:** 1 hora quinzenal.
- **Supervisão interdisciplinar:** 1 hora quinzenal.
- **Formato sugerido:** Presencial ou remoto, com pauta definida.

NÍVEL IDEAL (EXCELENTE)

- **Supervisão entre terapeutas da mesma área:** 1 hora semanal.
- **Supervisão interdisciplinar:** 1 hora semanal.
- **Formato sugerido:** Presencial ou remoto, com planejamento prévio e registro das discussões.

1.11.2 FREQUÊNCIA RECOMENDADA PARA ATs

A supervisão dos ATs deve combinar observação prática e análise indireta para assegurar a fidelidade das intervenções. Veja abaixo as recomendações por nível de qualidade:

NÍVEL RAZOÁVEL (MÍNIMO)

- **Supervisão direta:** 1 hora semanal (presencial ou remoto).
- **Supervisão indireta:** Não aplicável.
- **Total estimado:** 1 hora por semana.
- **Formato sugerido:** Observação direta ou por vídeo, com correções pontuais.

NÍVEL BOM

- **Supervisão direta:** 1 hora semanal (presencial ou por vídeo síncrono).
- **Supervisão indireta:** 1 hora semanal (vídeos, relatórios ou registros de dados).
- **Total estimado:** 2 horas por semana.
- **Formato sugerido:** Sessão estruturada com análise dos materiais enviados.

NÍVEL IDEAL (EXCELENTE)

- **Supervisão direta:** 1 hora para cada 10 horas de intervenção.
- **Supervisão indireta:** 1 hora para cada 10 horas de intervenção.
- **Total estimado:** Para 20 horas semanais de atendimento, recomenda-se 4 horas totais de supervisão.
- **Formato sugerido:** Avaliação contínua, prática assistida e *feedback* formal.



1.12 TREINAMENTO DE PAIS (MODELO BST)

O treinamento de pais é uma prática baseada em evidências, que visa sistematizar o repertório comportamental dos responsáveis para o manejo dos comportamentos dos aprendizes. É conduzido pelo supervisor do caso, que orienta os pais conforme os procedimentos definidos no plano de intervenção individual do cliente.

Etapas do treinamento:

- **Instrução:** Explicação clara das habilidades-alvo, inclusive por escrito.
- **Modelação:** Demonstração do procedimento.
- **Reprodução** (ensaio): Pais praticam com apoio.
- **Feedback:** Correções e reforço positivo.

1.13 INDICADORES DE QUALIDADE DO NÚCLEO ABA

Os indicadores de qualidade do Núcleo ABA são os seguintes:

- **Supervisões registradas:** Devem ocorrer em 100% das semanas.
- **Treinamento de pais ativo:** Realizado ao menos uma vez por mês para cada família.
- **Dados lançados no SociAutism:** Devem contemplar 100% dos atendimentos realizados.
- **Reuniões interdisciplinares:** Realizadas conforme a frequência da clínica, sendo o ideal que ocorram semanalmente.

1.14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Núcleo ABA deve garantir atendimento cientificamente fundamentado, focado em resultados mensuráveis e acompanhamento sistemático. A gestão eficiente depende de fluxos claros, responsabilidade compartilhada e dados confiáveis.



REFERÊNCIAS

ABA PARENTING TRAINING. **Tips for quality applied behavior analysis parent training**. ABAPT, 2019. Disponível em: <https://www.abaparenttraining.com/home/2019/3/7/aba-parent-training-tips-for-quality-applied-behavior-analysis-parent-training>. Acesso em: 12 maio 2025.

CROCKETT, Jennifer L. *et al.* Parent training: Acquisition and generalization of discrete trials teaching skills with parents of children with autism. **Research in developmental disabilities**, v. 28, n. 1, p. 23-36, 2007.

REIS NETO, Raymundo de Oliveira; TEIXEIRA PINTO, Ana Carolina; OLIVEIRA, Luiz Gustavo Azevedo. Acompanhamento terapêutico: história, clínica e saber. **Psicologia: Ciência e profissão**, v. 31, p. 30-39, 2011.

SELLA, Ana Carolina; RIBEIRO, Daniela Mendonça. **Análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista**. Curitiba: Appris, 2018.



EQUIPE EDITORIAL

AUTORIA

Fábio Coelho

DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO

Victor Cardoso

EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTO

Victor Cardoso

REVISÃO TÉCNICA

Càrol Lèal

CONSULTORES E ESPECIALISTAS

Fábio Coelho

Jenifer Macedo

Maria Christina Souza

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO

Academia do Autismo

REDES SOCIAIS



@maaisacademiadoautismo



@maaisacademiadoautismo



@academiadoautismo



@academiadoautismo

CONTATO



maais@academiadoautismo.com.br



(22) 99216-0282



academiadoautismo.com.br/maais

Este material é protegido por direitos autorais e não pode ser comercializado, distribuído, copiado, editado, alugado, transmitido ou reproduzido, total ou parcialmente, em qualquer meio de comunicação ou distribuição. Permissões para tais ações podem ser concedidas somente mediante autorização expressa do detentor e proprietário dos direitos do material. Qualquer violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais. Todos os direitos estão reservados à Academia do Autismo Ltda.